

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
CIENCIAS DE LA SALUD	MEDICINA	6

REGION DE FORMACIÓN		COMPLEMENTARIA					
CÓDIGO DEL CURSO		11170					
NOMBRE DEL CURSO		ELECTIVA INTERDISCIPLINAR					
TIPO DE CURSO		TEÓRICO	X		PRÁCTICO		
		DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL		
N° CRÉDITOS		3					
TIPO DE CRÉDITO		OBLIGATORIO				ELECTIVO	X
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)		48		HORAS TOTALES TEÓRICAS			48
				HORAS TOTALES PRÁCTICAS			
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)		96					
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)		144					
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO		ESPAÑOL					
MODALIDAD		PRESENCIAL	X	VIRTUAL			

PRE-REQUISITOS	
CÓDIGO	CURSO

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
72008149	HAROLD LLANOS
1047339668	JOSE LARIOS

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

El concepto de "rehabilitación" en Cuidados Paliativos es el menos desarrollado dentro de este movimiento, debido probablemente a la falta de estudios concluyentes sobre su eficacia, falta de bibliografía al respecto y escasa formación de los profesionales en este campo. El término de "rehabilitación" en Cuidados Paliativos ha suscitado desde el principio controversia. Algunos autores prefieren hablar del término adaptación y no de rehabilitación. En el año 2000, el Consejo Nacional de Cuidados Paliativos de Reino Unido definió la rehabilitación en Cuidados Paliativos de la siguiente manera: "La Rehabilitación en Cuidados Paliativos tiene que poner énfasis en la velocidad de respuesta y una cuidadosa planificación para tener en cuenta el deterioro. El personal debe ser capaz de ocuparse de la incertidumbre, mucho más que en las afecciones crónicas, y tienen que adaptarse constantemente a las situaciones potencialmente angustiosas. Debido a estas circunstancias especiales, el personal tiene que estar dispuesto a desdibujar sus funciones y a cruzar los límites profesionales que se trabajan en el campo de la rehabilitación"

El propósito de la rehabilitación es mejorar la calidad de supervivencia de manera que las vidas de los pacientes sean tan confortables y productivas como sea posible y que puedan funcionar con un mínimo nivel de dependencia cualquiera que sea su expectativa de vida. Se pretende formar en los estudiantes los fundamentos históricos de las terapéuticas físicas, naturales y complementarias y su independencia profesional dentro del marco de las ciencias biosanitarias. Desde una perspectiva histórico-social se ofrecen al alumnado los elementos críticos que permiten el análisis y la comprensión del estado actual de la salud en el cuidado paliativo.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

En las últimas décadas las características demográficas y epidemiológicas de la mayoría de los países muestran un aumento en la expectativa de vida. Si bien es un indicador de desarrollo, la longevidad y los cambios en el estilo de vida conlleva a un aumento de patologías crónicas que alcanzan un estado en el que ya no responden al tratamiento, por lo tanto, aumenta su sintomatología hacia el final de la vida. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, el 78% de ellas viven en países de bajos ingresos, y solo el 14% de las personas reciben asistencia paliativa. Según un estudio de 234 países, territorios y regiones realizado en 2011, los servicios de asistencia paliativa solo estaban adecuadamente integrados en 20 países, en tanto que el 42% de los países carecía de ese tipo de servicios, y un 32% adicional solo contaba con servicios de asistencia paliativa aislados. Enfermedades como las cardiovasculares (38,5%), cáncer (34 %), enfermedades respiratorias crónicas (10,3%), sida (5,7%) y diabetes

(4,6%). Muchas otras afecciones pueden requerir asistencia paliativa; por ejemplo, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, demencia, anomalías congénitas y tuberculosis resistente a los medicamentos.

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Seleccionar y aplicar modalidades físicas, cinéticas, neumáticas y/o educativas para el mantenimiento y optimización de las capacidades motrices y el mejoramiento de la calidad de vida, la vida independiente y la capacidad laboral de los individuos con deficiencias, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación y/o discapacidad debidas a alteraciones de los diferentes sistemas corporales, teniendo en cuenta los principios bioéticos, la práctica basada en la evidencia y los fundamentos teóricos de la profesión

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

Comentado [AM1]: Revisar las declarada por el programa, las encuentra en el Excel

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
Asistencial	Desarrollar habilidades de intervención orientadas a la protección y recuperación integral de la salud individual y colectiva, a través de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación basado en el método clínico que favorezca la reincorporación social en el curso de vida, o el final digno de una vida, aplicándolas con responsabilidad y con base en la evidencia científica disponible, acorde a los principios éticos y humanísticos con un enfoque global	Integrar los núcleos básicos de los cuidados paliativos, en aras de lograr una mayor protección a los derechos fundamentales a la salud y a la vida y muerte dignas. Obtener la mayor recuperación integral en los aspectos funcional, físico y mental, para promover su participación plena y efectiva en la sociedad, en condiciones de equidad con los demás miembros de la comunidad.	Prueba Mitad de carrera de competencias genéricas.
La investigación	Aplicar los componentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales del método científico para la formulación y desarrollo de procesos de investigación en salud desde una perspectiva crítica, reflexiva y ética, tendientes al mejoramiento de la prestación de servicios de salud que conduzcan al bienestar individual y colectivo acorde a las condiciones del entorno.	Evaluar los resultados de una de investigación para el mejoramiento de su accionar como profesional de la salud considerando el impacto ético y bioético de los procesos investigativos y actuar en consecuencia con la moral y la norma vigente.	Prueba Final de carrera de competencias genéricas Proyecto final

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: Conocer las bases de la comunicación, de la relación fisioterapeuta-paciente y el impacto psicológico que comporta la enfermedad, la muerte y el duelo. Conoce y señala las características fundamentales del dolor, los tipos y tratamientos, en lo relativo a fármacos y técnicas y su abordaje integral. Saber Hacer: Utiliza técnicas específicas diseñadas para mejorar síntomas y calidad de vida. Identifica y maneja las características de los Cuidados Paliativos en enfermedades y situaciones como: enfermedades crónicas avanzadas no oncológicas, enfermos en coma, demencias avanzadas, enfermedades infecciosas (VIH/SIDA), hepatitis C, pacientes geriátricos, terapia intensiva, pacientes como niños y adolescentes, ofrece modelos de organización y destaca alguna experiencia de trabajo en Cuidados Paliativos. Saber Ser: Conocer los principios bioéticos y su implicación en decisiones al final de la vida	Identifica las fases de adaptación ante la enfermedad en situación avanzada y/o final de vida. Describe las habilidades fundamentales de comunicación e información necesarias para ofrecer un trabajo más productivo en Cuidados Paliativos y comprender mejor la realidad de los enfermos y de sus familiares. Analiza e interpreta la información obtenida a partir de la evaluación para establecer programas de atención acordes con las necesidades del paciente/cliente. Aplica las técnicas específicas utilizadas para mejorar síntomas y calidad de vida	

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE POR UNIDADES

UNIDAD	1 INTRODUCCION AL CUIDADO PALIATIVO, DOLOR Y DUELO
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	
TEMAS	1. Definición de cuidados paliativos, su filosofía, fisiología del dolor sus principios básicos. 2. Actitudes de la sociedad ante la muerte y su influencia en la provisión de cuidados. 3. Niveles de asistencia paliativa, organización de recursos y tipos de estructuras organizativas específicas de cuidados paliativos. 4. Rol del profesional en el equipo multidisciplinar frente al dolor, el duelo a la muerte

UNIDAD	2. ENFERMEDAD Y FINAL DE LA VIDA
--------	----------------------------------

HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	
TEMAS	- Definición de enfermedad avanzada y/o final de vida. - Historia clínica completa, valoración inicial, diagnósticos de enfermería, intervenciones y planes de cuidados, evaluación y registro. - Paciente oncológico en fase avanzada y/o final de vida, enfermedades neurodegenerativas y crónicas en estado avanzado y/o final de vida. - Criterios de fase avanzada y/o final de vida. - Identificar los síntomas más comunes asociados con la enfermedad avanzada. - Principios generales del control de síntomas, valoración y evaluación de los síntomas de dolor crónico. - Reconocer la interrelación de los síntomas y su impacto sobre el individuo y familia desde una perspectiva global. - Entrevista clínica del paciente en duelo
TRABAJO INDEPENDIENTE	
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	
FORMA DE ORGANIZACIÓN	
EVALUACIÓN	

UNIDAD	3 PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO Y TÉCNICAS BÁSICAS
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	
TEMAS	- Función respiratoria. - Analgesia. - Autonomía - Relajación Dilemas éticos más frecuentes en cuidados paliativos: - Corrientes actuales de la bioética, incluyendo los «cuatro principios» (beneficencia, no-maleficencia, justicia y respeto por la autonomía), bioética del cuidado. - Consentimiento informado. - Sedación, doble efecto. • Voluntades anticipadas y testamento vital. - Eutanasia. - Sedación y situaciones relacionadas. - Requerimientos legales relativos a la muerte. - Multiculturalidad.
TRABAJO INDEPENDIENTE	
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE	
FORMA DE ORGANIZACIÓN	
EVALUACIÓN	

8. MÉTODOLÓGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

- Aprendizaje basado en Investigación
- Aprendizaje Basado en Problemas
- Aprendizaje Entre Pares
- Aprendizaje Cooperativo

Fomentar el diálogo: Se realizara actividades participativas, debate, mesa redonda y participaciones, donde se podrán resolver dudas conceptuales y realizar críticas constructivas fortalecer la libertad de pensamiento.

Propender por el desarrollo del pensamiento socio crítico, enfrentando la teoría-práctica-teoría, mediante actividad investigativa y la contextualización a fenómenos reales y propios de su cultura.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
TICS	Manejo en bases de datos institucionales e interinstitucionales
Investigación	Propuesta y ejecución de un plan de investigación para un programa relacionado con el cuidado paliativo, manejo del dolor o duelo.

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Búsqueda de información en bases de datos científicas electrónicas
- Consulta de recursos bibliográficos electrónicos y físicos en el Sistema de Biblioteca
- Lectura crítica de material científico
- Interpretar conceptos
- Socializar resultados de la actividad investigativa
- Referenciar bibliografía según las normas y área de conocimiento
- Citar autores en un informe

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMERA EVALUACIÓN	SEGUNDA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN FINAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	identifica las fases de adaptación ante la enfermedad en situación avanzada y/o final de vida. Describe las habilidades fundamentales de comunicación e información necesarias para ofrecer un trabajo más productivo en Cuidados Paliativos y comprender mejor la realidad de los enfermos y de sus familiares.	Analiza e interpreta la información obtenida a partir de la evaluación para establecer programas de atención acordes con las necesidades del paciente/cliente	Aplica las técnicas específicas utilizadas para mejorar síntomas y calidad de vida
EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE			
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DELPARCIAL	Mesa redonda, organizadores gráficos (cuadro comparativo, mente facto) exposiciones y examen escrito	Mesa redonda, video foro, ensayo, exposiciones y examen escrito.	Video foro, proyecto de aula, mapa conceptual, examen escrito.
MECANISMOS DE RETROALIMENTACIÓN	Directo en forma oral y escrita	Directa	Directa

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
			Mawani A, Khanzada S, Awerness of Palliative Care among Physical Therapy Student of ISRA University Hyderabad. Journal of Research & Method in Education.2015; 5(3).34-36.	
			Belchamber, Caroline, Elizabeth Rosser, and Caroline Ellis-Hill. "P-87 Physiotherapy palliative cancer care: a case study approach." (2017): A32-A32.	
			Przedborska, Agnieszka, et al. "The effect of physiotherapy on the condition of cancer patients receiving palliative care." <i>Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine</i> 8.2 (2016): 68-74.	
			Maddocks, Matthew, et al. "Palliative care and management of troublesome symptoms for people with chronic obstructive pulmonary disease." <i>The Lancet</i> 390.10098 (2017): 988-1002.	

Comentado [JL2]: Considero que esta bibliografía debe reajustarse y actualizarse para poder cumplir con el temario, pero me tomaría mas tiempo hacer la revision.

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA/ DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	Actividad diagnostica del cuidado paliativo, dolor y duelo.			
2-3	Revisión de lectura y mesa redonda de la Definición de cuidados paliativos, su filosofía, fisiología del dolor sus principios básicos.			
4	Mesa redonda de las actitudes de la sociedad ante la muerte y su influencia en la provisión de cuidados.			
5-6	Conversatorio sobre los niveles de asistencia paliativa, organización de recursos y tipos de estructuras organizativas específicas de cuidados paliativos.			
7	Conversatorio sobre el rol del profesional en el equipo multidisciplinar frente al dolor, el duelo a la muerte			
8	Mesa redonda sobre la definición de enfermedad avanzada y/o final de vida.			
	Seminario sobre la historia clínica completa, valoración			

9-10	Inicial, diagnósticos de enfermería, intervenciones y planes de cuidados, evaluación y registro.			
11-12-13	Presentación grupal del tema el paciente oncológico en fase avanzada y/o final de vida, enfermedades neurodegenerativas y crónicas en estado avanzado y/o final de vida.			
14	Presentación grupal de los criterios de fase avanzada y/o final de vida.			
15-16	Presentación sobre los síntomas más comunes asociados con la enfermedad avanzada además de los principios generales del control de síntomas, valoración y evaluación de los síntomas de dolor crónico.			
17	Debate sobre el impacto sobre el individuo y familia desde una perspectiva global del cuidado paliativo, dolor y duelo.			
17	Presentación sobre entrevista clínica del paciente en duelo			
18-19	Seminario sobre: • Corrientes actuales de la bioética, incluyendo los «cuatro principios» (beneficencia, no-maleficencia, justicia y respeto por la autonomía), bioética del cuidado. • Consentimiento informado. • Sedación, doble efecto. • Voluntades anticipadas y testamento vital. • Eutanasia. • Sedación y situaciones relacionadas. • Requerimientos legales relativos a la muerte. • Multiculturalidad.			
20	Examen final			